

פגיעות נוספות במערכת הנשימה

פגיעה בדרכי אוויר

נכחות של אוויר חופשי באזור הצוואר (אמפיזמה תת־עורית) או בית החזה מעורר חשד לפגיעה בדרכי הנשימה. קרעים באזור תיבת הקול נדירים מאוד. אלה מאובחנים על פי צרידות, אמפיזמה תת־עורית וקריטציות במישוש (תחושה כמו של ניילון בועות). אינטובציה תהיה הכרחית רק אם יש חשש שנוצרה חסימה מלאה של דרכי האוויר או אם יש מצוקה נשימתית קיצונית. ייתכן שלא יהיה אפשר להבטיח דרכי נשימה פתוחות, ויהיה צורך לבצע קוניוטומיה בשטח. ביצוע קוניוטומיה בשטח יכול לגרום להתפתחות אמפיזמה תת־עורית גדולה המתפשטת במהירות.

פגיעות בקנה בשל פגיעה קלה בדרך כלל אינן בולטות, במיוחד אם הנפגע מחוסר הכרה. לעומתן, פגיעות חודרות לקנה הנשימה בולטות הרבה יותר ודורשות התערבות כירורגית מיידי. הפגיעה מלווה בדרך כלל בפגיעה במבנה האנטומי של הקנה. בפגיעות ירי ייתכן נזק לרקמות הרכות בגלל אפקט החלל הנוצר מפגיעת הקליע.

במקרים כאלה, קשיים בנשימה וקוצר נשימה יהיו הסימנים הבולטים. יש לזכור שבעת הניסיון לבצע אינטובציה יש לצפות לפגיעה במבנה האנטומי של קנה הנשימה, דבר שיקשה להחדיר את הטובוס.

פגיעה בוושט

פגיעה בוושט בדרך כלל נגרמת מפגיעות חודרות. פגיעות קהות לוושט הן נדירות מאוד, אלא אם כן מכה פתאומית בבטן גרמה לעלייה פתאומית בלחץ התוך־בטני ולקרע של הוושט בגלל עלייה פתאומית של תוכן קיבה ואוויר. הטיפול יהיה בחדר ניתוח, ולא בשטח.

קרע סרעפתי

פגיעות חודרות יכולות לגרום לקרעים באזור הסרעפת. פגיעות אלו בדרך כלל הן ללא השלכות מיידי. מנגד, טראומה קלה יכולה לגרום לקרעים נרחבים של הסרעפת ולהיווצרות בקע בטני (מעבר של איברי הבטן לחלל בית החזה). משום שחלקה הימני של הסרעפת מוגן יחסית על ידי הכבד, הצד השמאלי נפגע בתדירות גבוהה יותר. הטיפול יהיה בבית חולים, בחדר הניתוח, לתיקון הקרעים.